

KC桌面——外资精译

Bernstein：直觉外科2Q26，美国增长趋势讨论升温

又一个财务表现强劲的季度。销售额增长19%至28.9亿美元，超出预期2.5%。器械与配件销售额增长18%至17.3亿美元，超出预期1%。系统销售额增长19%至6.85亿美元，基于468台达芬奇出货量（市场预期444台），超出预期4%。服务销售额增长21%至4.72亿美元，超出预期6%。每股收益增长28%至2.80美元，超出预期12%。市场每股收益预期将再次上调——我们2027年每股收益预期上调4%至12.71美元。

关于美国手术量增长趋势及其持续性的讨论再度升温。美国手术量增长（11.5%）较1Q26（13.5%）节奏变化，低于市场预期（13.2%）170个基点，ISRG引导读者关注13.5%-15.5%手术量增长指引的中值（实际上的指引下调）。ISRG将不及预期归因于ACA参保人数下降的不确定性——这将重新引发HCA周二公告所引发的担忧。ISRG还提到了"大数定律"——这将引发对美国增长持续性的质疑。我们的TAM分析表明，美国市场仍有多年的持续增长空间。

创新引擎持续运转。随着dV5、Ion、SP、XiR和My Intuitive+推动当前增长，ISRG正忙于创新：dV5用户界面更新、成像升级、延长使用器械，以及为胃肠道手术设计的新型柔性内窥镜系统提交510(k)申请。

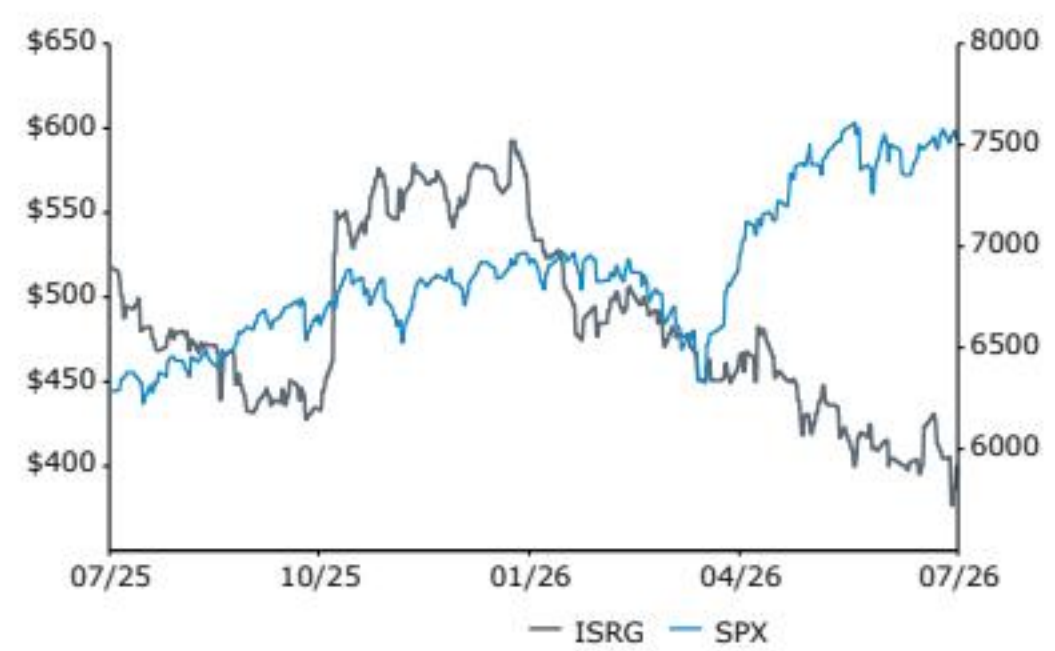
结论：对美国手术量增长趋势的担忧将引发讨论并对报价构成不确定性，尤其是在我们接近Q3（今年手术量增长对比最困难的季度）之际。我们预计报价将从盘后-11%的跌幅中回升，但如果报价维持在该水平（约360美元），估值倍数可能达到与EW持平的水平。我们认为400美元以下是极佳的入场点，建议您今年夏天花些时间研究ISRG。

来源：彭博、Bernstein估算与分析。

研究交流：公司情况更新

我们给予ISRG"跑赢大盘"评级，采用50倍市盈率（此前为59倍），基于我们对Q5-Q8远期每股收益13.66美元（此前为12.69美元）的预测。更多内容请参见我们对Intuitive 1Q25的回顾。模型：ISRG

一年期价格表现



图表 1

来源：彭博、Bernstein估算与分析。

详情：公司情况更新

又一个财务表现强劲的季节

销售额超出预期2.5%。收入28.9亿美元，增长19%，较市场预期（28.2亿美元）高出2.5%。分板块看，器械与配件销售额增长18%至17.3亿美元，较市场预期（17.2亿美元）高出1%，得益于全球达芬奇手术量增长14.7%（略低于市场预期的14.9%）。系统收入增长19%至6.85亿美元，较市场预期（6.57亿美元）高出4.2%，因达芬奇系统装机量（468台）超出预期5.4%。系统平均售价159万美元，同比增长6.0%，但低于预期的167万美元，原因是换购比例上升以及低平均售价的X和XiR系统占比提高。服务收入增长21%至4.72亿美元，较市场预期（4.47亿美元）高出5.6%。

毛利率为70.0%，较市场预期（67.8%）高出约220个基点。ISRG在本季度录得3600万美元的IEEPA关税退税收益，贡献了220个基点毛利率利好中的约125个基点（不含关税收益的毛利率约为68.7%）。与2Q25（67.9%）相比的同比增幅反映了产品成本降低和固定制造费用杠杆效应。

营业利润率为42.1%，较市场预期（38.7%）高出约340个基点，得益于dV5和SP的强劲采用，以及此前支付的IEEPA关税退税带来的3600万美元税前收益（不含关税收益的营业利润率约为40.9%）。

每股收益2.80美元，增长28%，较市场预期的2.50美元高出11.9%，其中包括与关税退税相关的每股摊薄收益0.08美元。剔除关税收益后，每股收益2.72美元，增长24%，较市场预期高出8.7%。

公司回购。Intuitive在2026年第二季度以3.8亿美元回购了90万股普通股。正如我们过去所指出的，Intuitive在回购自身公司方面有着良好的记录。过去四个季度，Intuitive已回购约36亿美元的自身公司——大致相当于同期的自由现金流。管理层认为公司可能会继续这一回购策略。

美国手术量增长节奏变化重新引发医院利用率担忧

暗流涌动的担忧达到沸点。过去几个月，医院的评论引发了市场对2H26利用率增长可能节奏变化的担忧，部分原因是ACA计划参保人数下降和Medicaid削减。当HCA周二预发布2Q26收入时——强调同院住院手术量下降2.3%，同院门诊手术量下降3.4%——这些担忧达到沸点，医疗科技股下跌3%-7%（参见我们对HCA预发布的要点总结）。

来自JNJ/ABT/UNH的缓解。周三，JNJ评论称他们（1）未发现基础手术市场节奏变化的迹象，（2）未受到ACA或Medicaid参保人数下降的影响。事实上，JNJ预测其所有四个医疗科技业务从1H26到2H26将加速增长（参见JNJ回顾）。随后在昨天，ABT首席执行官Robert Ford对医疗科技市场健康进行了有力辩护，声称（1）ABT未发现手术趋势节奏变化的迹象，（2）关于医疗科技手术面临不确定性的担忧基于“有缺陷的假设”，即ACA或Medicaid参保人数下降对医疗科技市场有影响（参见ABT回顾）。加上UNH（Wilkes）手术量符合预期的鼓舞，医疗科技股周四上涨。

ISRG重新引发担忧。如图表1所示，美国达芬奇手术量增速从3Q25的16%节奏变化至4Q25的15%，再至1Q26的14%和2Q26的12%。当读者看到美国手术量趋势出现看似急剧的节奏变化时，关于利用率增长节奏变化的担忧重新被点燃。在财报电话会议上，管理层解释说，节奏变化趋势的主要驱动因素是ACA增强保费补贴到期以及随后ACA参保人数下降。ISRG认为美国手术量增长节奏变化的大部分——但并非全部——与ACA相关。对于剩余200个基点的节奏变化，管理层引用了“大数定律”，即随着手术量达到足够大的基数，百分比增长率将不可避免地节奏变化，即使绝对手术数量继续上升。

“...实际上我们关注两件事。首先也是最重要的是来自客户的反馈，我们观察他们与我们相关的手术趋势，并与他们沟通他们所看到的情况。如果你看那些我们知道其中一部分可以推迟的手术类型。我们看到手术趋势方面存在差异，特别是在Q2，相对于那些不太可推迟或不可推迟的手术，所以这只是这两件事的结合。如果你看我们在Q2看到的情况，美国达芬奇手术量总体增长为12%，而Q1为14%，这可能是ACA影响和

我们也在一定程度上看到了大数定律的影响。”

哪些手术推动了增速节奏变化？

在后续沟通中，管理层澄清了美国手术增长节奏变化的原因及受影响的手术类型。团队指出了三类手术：(1) 良性子宫切除术，以及(2) 疝气和(3) 胆囊切除术（症状较轻的亚类）。减重手术在第二季度因GLP-1药物使用增加而出现高个位数下降，目前占全球达芬奇手术量的略高于2%（其中80%在美国）。美国减重手术在第一季度下降了10%，因此并非第一季度至第二季度增速节奏变化的主要因素。

大数定律：公司情况更新

如果有一个词能让对是否持有ISRG犹豫不决的读者感到不安，那就是“大数定律”。多年来，读者一直担心美国手术机会的“饱和”可能就在眼前。当然，没有人相信美国达芬奇手术增长能永远保持在15%。但相信美国手术增长能在相当长一段时间内保持两位数并非不合理。在与管理层的后续沟通中，团队承认他们本意是强调ACA参保人数下降是第一季度至第二季度增速节奏变化的主要原因。他们提到大数定律可能是增速节奏变化的一个因素，但无意让读者过度解读。

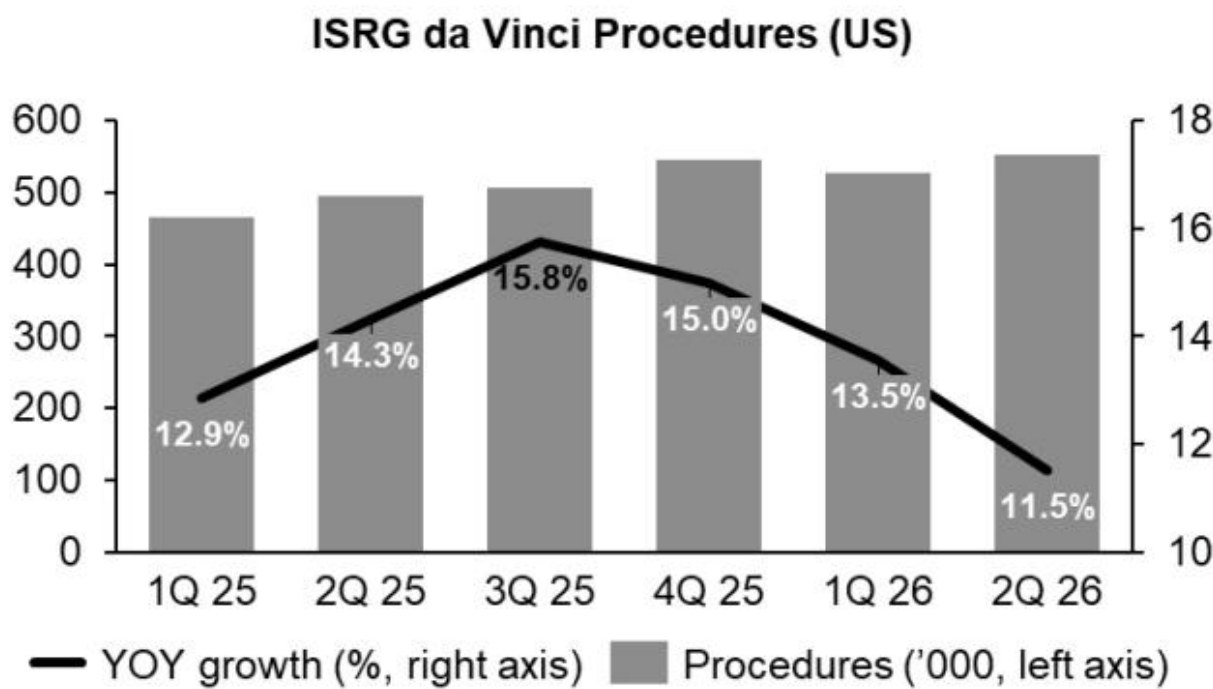
美国市场仍有大量机会

我们的市场模型研究表明，美国手术增长仍有大量机会。直觉外科管理层在后续电话会议中也强调了这一点。除了核心手术组合的持续增长外，团队还指出了几个将继续推动美国手术增长的重点领域

- 非工作时间手术在第二季度增长了26%，团队继续与医院合作，挖掘利用未充分利用的系统容量进行非工作时间手术的机会。
- 良性妇科手术——包括骶骨阴道固定术、子宫内膜异位症手术、卵巢切除术和肌切除术——在美国第二季度增长了19%。直觉外科继续研究于额外的临床资源以支持这些领域的增长。
- 几项高增长的美国良性普通外科手术（例如前肠、胃切除术、HPB手术）在第二季度合计增长了16%，ISRG认为这里仍有机会。
- 直觉外科指出了ASC、心脏手术和保留乳头乳房切除术中的几个早期机会，这些领域的增长在未来几年可能大幅加速，并为美国手术增长做出有意义的贡献。
- 团队提到他们正在研究几个额外的手术机会，但尚未准备好讨论。

总而言之，尽管第二季度美国手术增速节奏变化必然会引起关注，但我们远未触及美国手术增长机会的上限。同样重要的是要记住直觉外科管理层在第一季度提出的“创新驱动收入增长”概念。手术增长在未来许多年仍将是一个关键指标，但ISRG正在为手术带来大量额外价值，即使在某个阶段手术增长率开始节奏变化，也有助于推动收入增长。

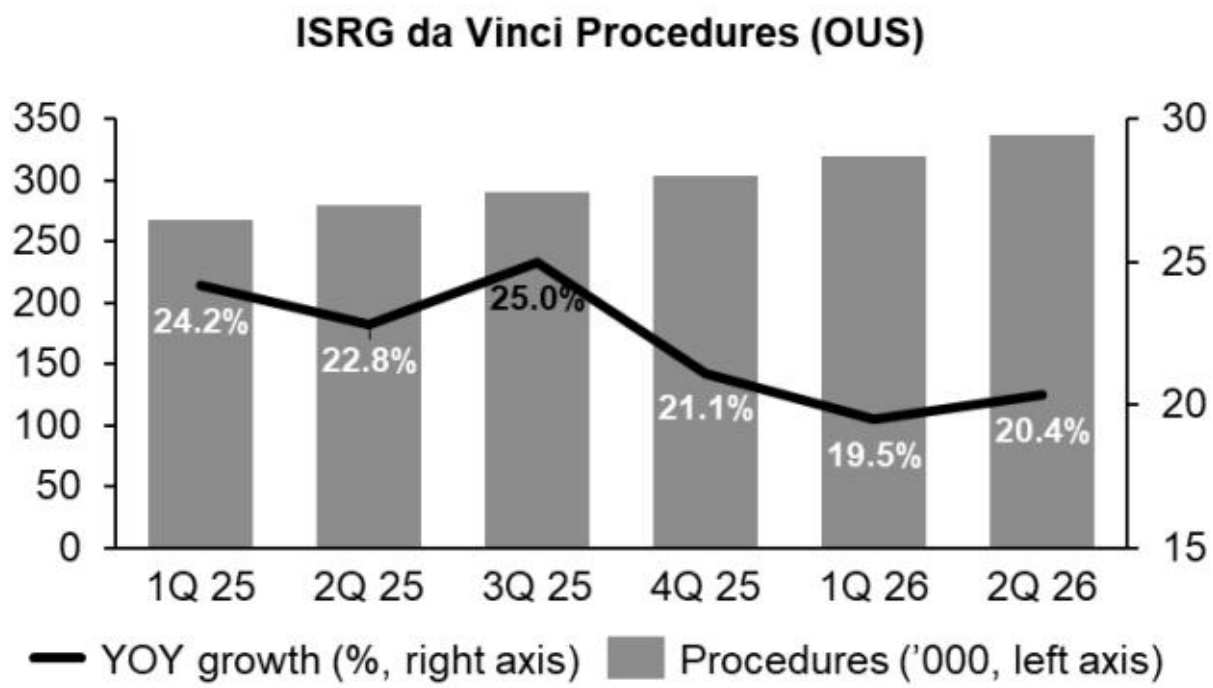
图表1：美国达芬奇手术增速从1Q26到2Q26节奏变化了200个基点*



图表 2

*考虑到第二季度更难的同比基数，两年叠加的手术增长减速不那么明显，从第一季度的26.4%降至第二季度的25.8% 来源：公司报告；Bernstein分析

图表2：美国以外达芬奇手术增速在较易基数上略有加快*



图表 3

*考虑到第二季度更易的同比基数，两年叠加的手术增长趋势从第一季度的43.7%降至第二季度的43.2% 来源：公司报告；Bernstein分析

全球手术增长弱于预期

达芬奇手术在2026年第二季度全球增长14.7%，比市场一致预期（14.9%）低20个基点，其中美国手术增长12%。美国手术增长由普通外科引领，非工作时间手术增长26%，但受ACA影响，可推迟手术有所缓和。管理层有信心这些推迟的病例将会恢复。

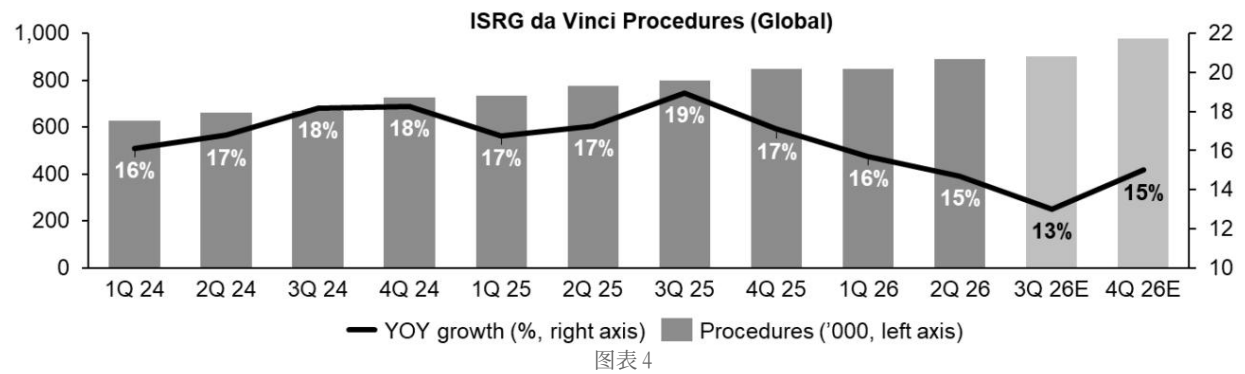
“美国增长从近期趋势和年初预期有所节奏变化，主要发生在可推迟的手术中。在与客户的沟通中，一些人表示，患者保险覆盖和保费动态的变化可能影响患者何时寻求护理并进行治疗。重要的是，潜在的疾病负担没有改变，可推迟的病情通常会进展并最终需要治疗。当患者恢复护理时，我们预计达芬奇仍将是其外科医生和护理团队的明确选择。”

在国际市场，达芬奇手术在2026年第二季度增长20%，印度、意大利、台湾和英国表现尤为强劲，分销商市场和德国也实现稳健增长。中国和日本的达芬奇手术增长略高于全球平均水平，但继续受到影响。在中国，手术受到招标活动减少、竞争加剧和政策驱动的定价不确定性的影响。在日本，过去几个季度较低的资本设备投放对手术造成了不确定性，但管理层对6月1日生效的支持机器人手术的新政策持乐观态度。在印度，dv5还获得了许可。

“在中国，环境仍然充满挑战。我们继续看到招标活动减少、国内机器人竞争加剧以及政策驱动的定价仍在调整，我们继续在动态的政策环境中运营，包括收费代码变更和第十五个五年计划配额流程。我们正在与省级政府就收费代码政策进行沟通，并正在推进SP和达芬奇5的绿色通道流程。一旦获批，这些平台将为中国客户及其患者带来额外的差异化能力。在日本，支持机器人手术的新政策于6月1日生效，包括为额外手术提供报销，以及为更高利用率项目提供宏观环境激励。我们对政策环境的方向以及对这些举措的早期反应感到鼓舞。”

美国达芬奇平均利用率增长了3%，部分原因是利用率更高的达芬奇5系统装机量不断增加。

图表3：达芬奇手术在2026年第二季度全球增长14.7%，比市场一致预期（14.9%）低20个基点



来源：公司报告；Bernstein估计与分析

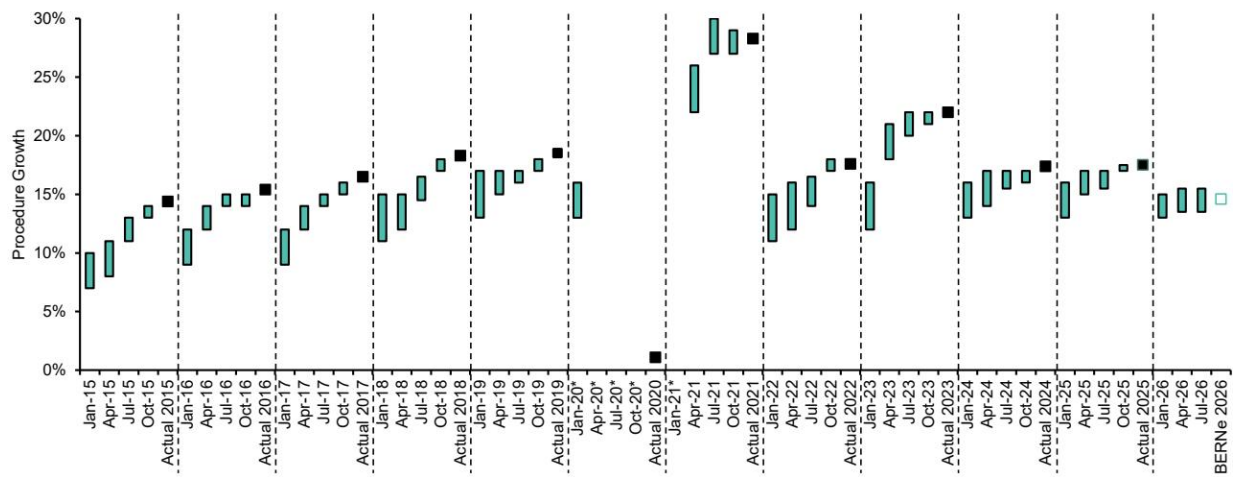
维持2026财年手术指引；预计接近中点

直觉外科维持2026财年手术增长指引不变，为13.5%至15.5%，并补充说管理层预计将接近该范围的中点。这出乎意料，因为读者已经习惯了手术增长方面相当稳定的超预期和上调指引（见图表4）。在后续沟通中，管理层澄清，维持（而非上调）指引的决定主要是由于ACA影响导致美国手术节奏变化。

我们继续认为，主要增长驱动力将是美国普外科手术，包括国际非泌尿科领域的非工作时间手术和操作。我们的区间考虑了美国ACA保费补贴变化和患者行为、中国招标量和该市场竞争强度、欧洲部分地区因宏观宏观环境影响和政府优先事项变化带来的资本不确定性、日本此前的资本挑战以及这些挑战在2026年对肥胖管理药品领域持续多久的影响。

图表4：ISRG通常每季度上调手术增长指引；在2026年第二季度，管理层将2026财年指引维持在13.5%-15.5%，并引导读者关注区间中值

ISRG手术增长指引变化与实际对比

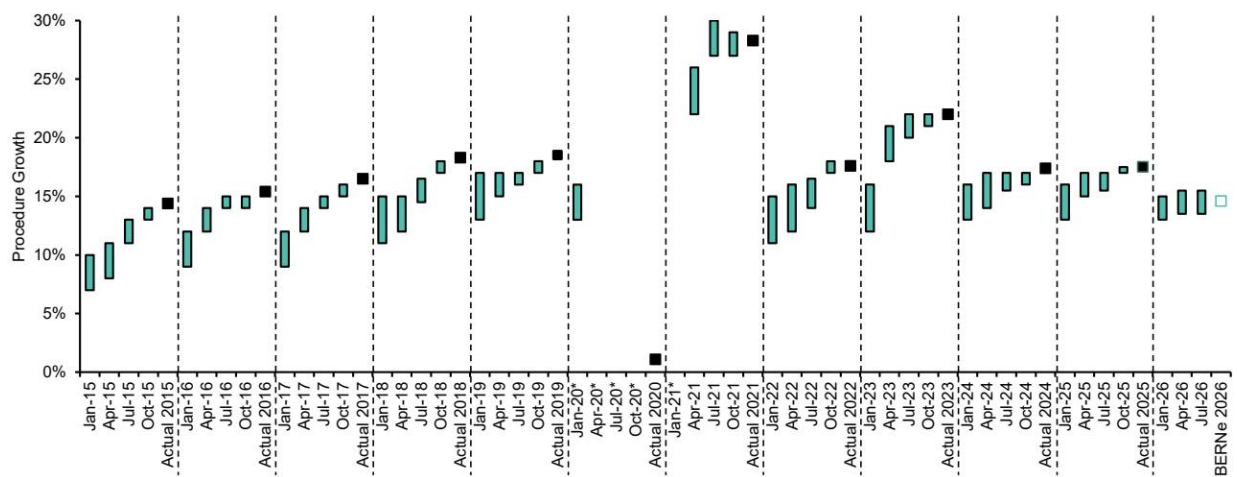


图表 5

来源：公司报告；Bernstein估算与分析

如图表5所示，2026财年全年毛利率指引也上调了50个基点，在运营支出增长方面，管理层将区间上限下调了一个百分点。

图表5：ISRG维持2026财年手术增长指引并引导读者关注区间中值，将毛利率指引上调50个基点，并将运营支出增长指引上限下调一个百分点



图表 6

来源：公司报告；彭博；Bernstein估算与分析

出货量强劲；dV5势头只会随时间增强

直觉外科在第二季度出货了468套达芬奇系统，超出市场共识（444套）5.4%，达芬奇装机量同比增长18%（2025年第二季度为395套）。在468套出货量中，246套为达芬奇5系统（包括114套双控制台），使dV5累计装机量超过1700套。这一强劲超预期表现表明，尽管手术增长指引更为保守，但资本设备季度表现强劲。

dV5出货量只会随时间进一步改善。管理层将达芬奇5升级周期描述为仍处于早期阶段，直接指出从Si到Xi的过渡中，大约用了7年时间才达到换购量峰值。随着平台持续发展、软件不断改进，直觉外科认为未来还有多年的增长空间。

"我认为我们没有完美的预测。我只想说，看看——当我们推出Xi时，从Si到Xi的换购量达到峰值大约用了七年时间。我仅将此作为历史参考，别无他意。我认为，与Xi一样，达芬奇5及其生态系统的能力会随着软件更新和生态系统其他要素的改进而随时间增强。每次我们进行这些更新，都会使系统更具吸引力。当然，美国市场会存在一定细分，可能取决于ASC和HOPD根据其操作组合与医院相比的偏好。但我们已经说过一段时间了，我们认为升级周期是渐进的，会持续多年。"

中国疲软、日本乐观、印度强劲。在地域方面，中国仍面临挑战，原因是招标活动减少、国内竞争加剧以及政策驱动的定价仍在调整。本季度，直觉外科在中国安装了两套系统，包括他们在香港的首套dV5系统（dV5目前尚未在中国大陆获批）。另一方面，直觉外科对日本的政策环境持"谨慎乐观态度"，该公司在日本安装了25套系统（2025年第二季度为15套）。

"在中国，环境依然充满挑战。我们继续看到招标活动减少、国内机器人竞争加剧以及政策驱动的定价仍在调整。我们仍在应对动态变化的政策环境，包括收费代码变更和第十五个五年计划配额流程。我们正在与省级政府就收费代码政策进行沟通，并正在推进SP和达芬奇5的绿色通道审批流程。获批后，这些平台将为中国的客户及其患者带来额外的差异化能力。在日本，支持机器人手术的新政策于6月1日生效，包括为额外手术提供报销以及为高利用率项目提供宏观环境激励。我们对政策环境的方向以及对这些举措的早期反应感到鼓舞。"

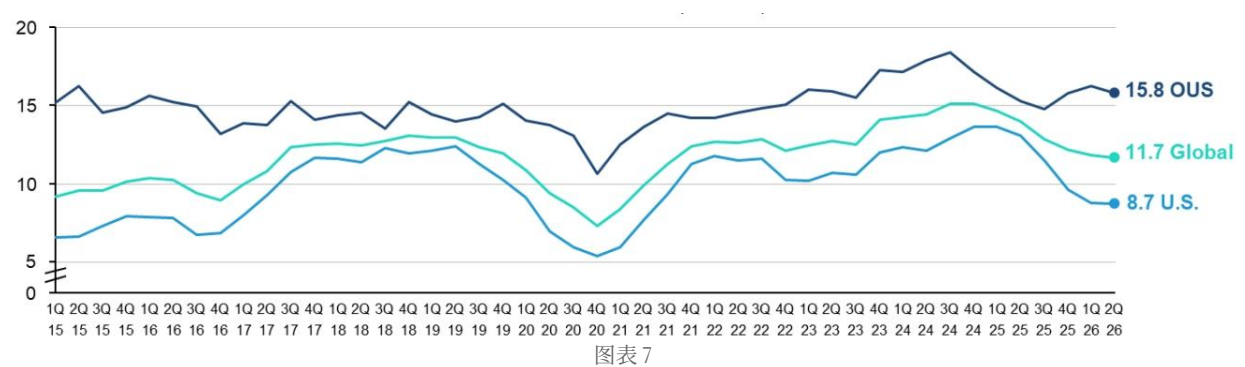
管理层指出，印度是第二季度的突出表现者，再次交出强劲季度成绩，并于本周获得dV5监管批准，使该公司能够将其最新平台带入该市场。

稳定的资本支出环境。管理层将美国资本环境描述为目前稳定。第二季度，美国装机量增长24%至267套系统（2025年第二季度为216套），几乎全部增长来自换购/升级。

"美国资本环境，至少根据我们的经验，已经稳定了一段时间。我认为，从第二季度美国健康的系统装机量（增长24%）中可以看出这一点。我确实认为我们有一个相对优势——在美国，大约70%的系统是通过租赁安排获得的。我认为，这使客户在面临资本预算限制时拥有更大的灵活性。但我认为，我们对近期美国资本设备的表现感到满意。"

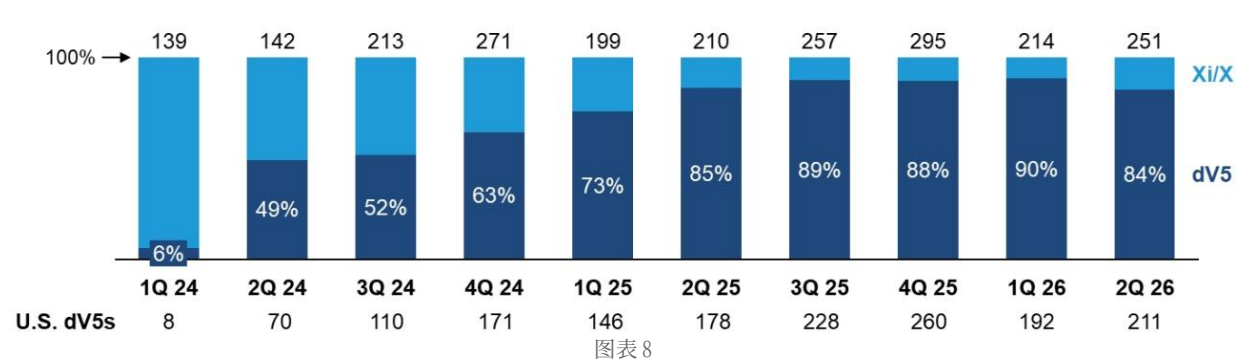
该公司还看到本季度新市场开拓有所增加，主要来自向ASC出货的27套系统。管理层还强调，虽然一些客户对ACA参保趋势表示谨慎，但到目前为止，他们尚未看到这对其管线产生影响。

图表6：美国达芬奇装机量增长率稳定在8.7% 达芬奇装机量增长（%，同比）



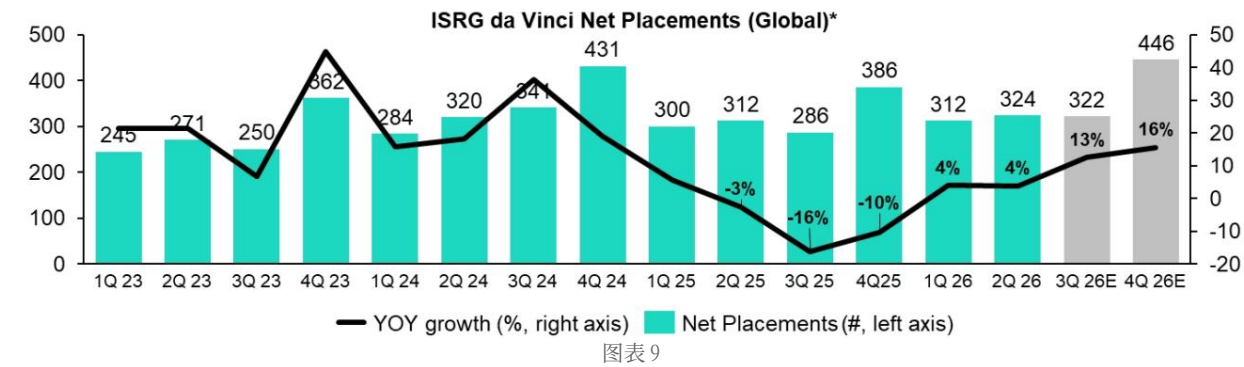
来源：公司报告；Bernstein分析

图表7：在美国，客户继续对dV5表现出浓厚兴趣（占多孔系统出货量的84%）*
按型号划分的美国多孔系统装机量



*注：美国翻新Xi（XiR）装机量从2026年第一季度的8套增加到2026年第二季度的28套
来源：公司报告；Bernstein分析

图表8：全球净达芬奇装机量增长同比稳定在4%



*定义为达芬奇总出货量（含SP）减去换购量 来源：公司报告；Bernstein估算与分析

第一阶段超过100项更新旨在提升dV5能力

5月21日，直觉外科宣布了dV5第一阶段超过100项更新和用户体验改进，旨在改善远程呈现、基于模拟的培训和护理团队工作流程。管理层澄清，大多数更新对客户而言是不可见的，专注于提高平台的效率和有效性。其中三项功能也已提交510(k)审批，包括：(1)数字标尺，可实现术中屏幕测量；(2)医生启动工具弹出，允许医生直接从控制台移除器械/内窥镜；(3)多臂瞄准，允许使用任意数量的对接臂进行瞄准。管理层强调，鉴于dV5强大的计算能力，直觉外科将能够通过定期增加功能和特性来持续强化该平台。

“……关于我们承诺的这一节奏，随着我们将达芬奇5作为平台及其万倍计算能力，我们能够定期为其增加功能和特性。因此，你提到的新闻稿包含了100项更新。其中一些更新对客户来说是不可见的，可以说是‘引擎盖下的改进’，而许多更新对客户是可见的，并且集中在之前讨论过的领域。其中3项特别利用了这些更新，我们已提交510(k)许可申请。[……]其中2项侧重于[……]可用性和效率特性，例如，护理团队和外科医生可能能够减少在手术工具注射功能上的来回沟通，他们可以精确指示需要更换哪把工具。另一项是，我们能够在术前或手术过程中调整多个机械臂，这将有助于提高手术效率。现在我们终于还增加了数字标尺，这是另一项需要许可的功能。可以想象，在各种手术中，外科医生可以用它来测量解剖结构的特定部分，以确保满足患者需求。这就是我们提交许可申请的3项更新。其他更新将围绕系统的效率和有效性展开。展望明年及以后，您将看到一系列更新，其中许多将是提升系统能力的突出功能。”

每台手术的I&A收入增长，部分受力反馈技术采用率上升推动

总I&A收入增长18%至17.3亿美元，比市场一致预期（17.2亿美元）高出1%。达芬奇每台手术的I&A收入也有所增长，从2025年第二季度的1,800美元增至1,830美元。管理层将此归因于SP和dV5手术占比提高，但被客户订购模式、胆囊切除术手术增加以及减重手术减少所抵消。直觉外科还强调，力反馈器械的采用率上升是达芬奇每台手术I&A收入的另一推动因素。

延长使用计划。该计划于5月宣布，将于2027年上半年启动，直觉外科预计将增加部分EndoWrist器械的使用次数，旨在降低客户每台手术成本，并支持dV手术的更广泛采用——尤其是在良性手术和成本限制可能更大的地区。最终，直觉外科在EUP背后的目标是“强化一个良性循环，即更低的成本支持更广泛的采用，从而推动利用率和规模，进而促进我们平台的持续创新。”值得注意的是，管理层确认，力反馈器械以及吻合器和能量产品将被排除在即将推出的延长使用计划之外。直觉外科仍在最终确定定价，并预计将在2026年第三季度电话会议上量化其影响。目前，我们预测从2026年到2027年，每台手术的I&A收入将下降约3%。

为新型胃肠道机器人提交510(k)申请

作为直觉外科致力于覆盖更多患者并推进探索机器人辅助技术在新型疾病领域应用的早期研发项目的一部分，该公司已为一种新型胃肠道机器人提交了FDA 510(k)许可申请。具体而言，这是一种用于胃肠道的“基础性、非商业性、下一代柔性机器人内窥镜系统”，直觉外科对该机器人在为更多患者带来更好的微创护理方面的潜力感到兴奋。管理层指出，新系统将具有“治疗”应用，暗示其不会仅专注于诊断（例如结肠镜检查）。

My Intuitive+首轮续约实现100%留存

本季度，直觉外科执行了My Intuitive+的首轮续约——这是dV5集成的远程呈现模拟和AI驱动手术洞察服务——此前免费试用期在本季度开始到期。虽然初始续约群体规模较小（我们估计约350套系统），但没有客户选择退出其My Intuitive+安排。该服务的定价约为每套系统每年4万美元。虽然初始影响较小，但随着每季度出货的达芬奇5系统的一年免费试用期逐步到期，其影响将随时间增长。

附录 - 财务预测

图表9：直觉外科（ISRG）财务模型

来源：公司报告；Bernstein估计与分析

Bernstein公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 来源：彭博，Bernstein估计与分析